法的脳死判定を初めて実施した一例

◎西田 昂平[1)]、林 晃司[1)]、清水 結都[1)]、南 裕貴[1)]、佐々木 真奈美[1)]、藤本 伸吾[1)]、堀出 剛[2)]
社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院[1)]、公益社団法人 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院[2)]

【はじめに】法的脳死判定は厳密な手順と多職種の協力が求められる医療行為である。今回、初めて携わる機会を得た法的脳死判定の運用と課題を報告する。

【当院背景】2024 年度より法的脳死判定の運用開始に向けて準備が開始された。2025 年度に運用開始の準備が整い、名古屋掖済会病院の連携体制構築事業に加入後、JOT の確認を経て運用開始となった。

【症例】10 代男性。搬送時、Vf と判断され電気ショック実施、その後 HR40 程度。GCS1/1/1、瞳孔散大 5/5mm、対光反射直接間接ともになし、角膜反射なし、咳反射が残っていた。蘇生後脳症と診断されたが、バッキングもあり完全な全脳死には該当しない状態であった。

【経過】搬送から 48 時間経過した脳 CT においては皮髄境界が不明瞭化した状態がはっきりしているが、一部明瞭な部分も存在し、下顎呼吸様の反射が認められた。

搬送から 84 時間経過した頃、sBP50 台に急激に低下、心エコーでは EF20%程度となり脳浮腫、低酸素脳症の進行が確認された。また、バッキングや吃逆も消失した。

その後、脳幹反射の確認および高感度脳波を実施し、脳死とされうる状態であると判断された。ご家族の意思が確認され、第一回法的脳死判定および第二回法的脳死判定を実施後、ご家族様立会いのもと死亡宣告となった。

【考察】高感度脳波測定は通常の脳波検査との違い、機器間や電極間距離の測定や環境によるノイズの除去が重要であることが学べた。また、脳幹反応の消失や無呼吸テストなど法的脳死判定に必要な検査を多数実施する必要がある。そのため、医師と情報共有を行い時間に追われないように余裕をもって事前準備を行う必要があると感じた。

【まとめ】法的脳死判定を経験したことによって得たスキルや知見を共有し要員を育てることで、いつでも対応できるような体制を準備しておくことが重要である。そのために不安点の洗い出しを行い、確実にかつ円滑に検査を終えられるような体制を整えていく予定である。

連絡先:0586-48-0070